7.1 감염예방·관리체계 구축 및 운영			
규 정 번 호	7.1	제 정 일	
관 련 인증기준	7.1 감염예방·관리체계 구축 및 운영	최근 개정일	
담 당 부 서	감염관리실	시 행 일	
검 토 책 임 자	병원운영위원회	검 토 주 기	2년
승 인 책 임 자	병원장	검토 예정일	
관 련 근 거	1. 의료법 시행규칙 제 43조, 제44조, 제46조 2. 의료관련 감염 표준예방지침		

▣ 목적 (Purpose)

감염발생 위험을 감소시키기 위하여 감염예방 및 관리를 위해 기획, 통합, 조정, 지원하기 위한 체계를 운영함으로써 지속적인 조직문화의 변화를 지향하여야 한다.

▣ 정책 (Policy)

1. 감염예방 및 관리에 대한 규정이 있다.
2. 감염예방 및 관리를 위한 위원회를 운영한다.
3. 감염예방 및 관리활동을 수행하는 부서 및 적격한 자가 있다.

▣ 지침 및 절차 (Guidelines & Process)

1. 감염예방 및 관리를 위한 위원회 활동

가. 감염관리 위원회의 구성 및 임기

1) 위원장 1명을 포함하여 7명 ~ 15명으로 구성한다.
2) 위원장은 본원의 병원장이며, 부위원장은 위원중에서 위원장이 지명한다.
3) 위원은 다음 각호에 어느 하나에 해당하는 사람과 병원장이 위촉하는 외부 전문가로 한다.
   가) 감염관리실장
   나) 진료부서의 장
   다) 간호부서의 장
   라) 감염 관련 의사 및 병원장이 필요하다고 인정하는 사람
4) 위원회의 사무를 처리하기 위하여 감염관리 담당자가 위원회의 간사가 된다.
5) 위원의 임기는 부서의 재직기간으로 하며 위촉 위원은 2년으로 하며 연임할 수 있다.

나. 위원회의 역할

1) 감염관리 위원회는 의료기관의 감염관리 활동의 기획, 통합, 조정, 지원을 하며 다음 사항을 심의 의결한다.
   가) 의료관련감염에 대한 대책, 연간 감염예방계획의 수립 및 시행에 관한 사항
   나) 감염관리요원의 선정 및 배치에 관한 사항
   다) 감염병환자등의 처리에 관한 사항
   라) 병원의 전반적인 위생관리에 관한 사항

마) 병원감염관리에 관한 자체 규정의 제정 및 개정에 관한 사항
바) 그 밖에 의료 관련 감염관리에 관한 중요한 사항

다. 위원회의 운영

1) 정기적 위원회 운영 : 위원회는 연 4회 이상 정기적으로 개최함을 원칙으로 한다.
2) 비정기적 위원회 운영 : 위원장 및 위원 과반수이상이 필요하다고 인정할 때 수시로 소집할 수 있다.
3) 회의는 재적인원 3분의 2 이상 참석으로 성립하며(업무출장, 환자진료 등 특별한 사유로 위임장 제출 시 출석으로 갈음 함) 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다. 다만, 위임장 제출을 포함하여 회의 성원요건이 되었다 하더라도 실제 참석 정족수는 재적위원 과반수이상이 되어야 하며, 의결 시 가부동수인 경우에는 위원장이 결정한다.
4) 위원장은 위원회를 대표하며 업무를 총관한다.
5) 위원회는 회의록을 작성하여 참석자의 확인을 받은 후 비치한다.
6) 그 밖에 위원회의 운영에 필요한 사항은 위원장이 정한다.

라. 위원회 운영 결과 경영진 보고

1) 위원회 회의를 운영 후 그 결과는 위원회 회의록을 작성하여 병원장에게 보고한다.

2. 감염예방 및 관리활동 수행 부서 및 인력

가. 감염관리실(부서)의 역할

1) 병원감염의 발생 감시
2) 병원감염관리 실적의 분석 및 평가
3) 직원의 감염관리교육 및 감염과 관련된 직원의 건강관리에 관한 사항
4) 그 밖에 감염관리에 필요한 사항

나. 감염관리실 업무를 수행하는 사람의 인력 배치 및 자격 기준

1) 실무 수행에 적합한 경력 및 자격
가) 감염관리실에서 감염관리 업무를 수행하는 사람은 감염관리에 관한 경험 및 지식이 있는 사람으로서 의료기관 경력 1년 이상으로 하며 의료법 시행규칙 별표 8의 2에 따라 의사, 간호사, 병원장이 인정하는 사람으로 각 1명씩 배치한다.
2) 감염예방 및 관리활동을 위한 교육 및 훈련
가) 감염관리실에서 업무를 수행하는 사람은 의료법 시행규칙 별표 8의 3에 따라 감염관리 교육을 매년 16시간 이상 이수한다.
나) 감염예방 및 관리활동을 위한 훈련이란 국내외 학회, 감염관리 연수과정, 정보와 데이터의 관리, 분석, 활용을 위한 훈련 등이 있다.

3. 의료기관 전체 차원의 감염예방 및 관리 활동을 위한 연간계획 수립

가. 우선순위 선정 기준

의료관련 감염 감시와 감염관리위험사정을 통해 우선순위를 선정한다.

나. 우선순위에 따른 감염예방 및 관리활동의 선정

우선순위에 따라 선정된 감염예방활동의 계획과 목표를 설정하여 아래와 같이 관리활동을 실시한다.

다. 활동내용

1) 감염 감시 활동 : 손위생 수행 모니터링 등
2) 교육계획 : 연간 감염관리 교육에 관한 사항
3) 감염예방 및 관리 활동을 위한 의료기관의 지원
가) 손위생 포스터 제작, 캠페인 등

라. 성과 평가 계획

1) 의료기관 전체 차원의 감염예방 및 관리 활동계획 수립 시 성과를 평가하여 차기년도 연간 계획 수립 시 반영한다.

마. 감염예방 및 관리 위원회의 검토・승인, 경영진 보고

1) 감염예방 및 관리 활동을 위한 연간 계획 수립 및 활동에 대해서는 감염관리위원회에서 검토 및 승인하고 경영진 및 병원장에게 보고한다.

4. 감염예방 및 관리 활동 계획에 따라 경영진은 필요한 자원을 지원한다.

가. 인적, 기술적 지원 : 감염관리 실무에 적합한 전문교육 및 훈련을 지원한다.

1) QPS활동 도구, 모니터링 도구 개발
2) 정보와 데이터 관리, 분석, 활용을 위한 훈련
3) 컴퓨터(microsoft office) 활용 능력 향상을 위한 훈련
4) 지표 및 통계교육을 통해 데이터 관리 훈련 등

나. 행정적 지원

1) 감염예방 및 관리활동을 위한 손위생 포스터 제작 지원
2) 감염예방을 위한 캠페인을 시행할 수 있다.
3) 회의비, 교육비, 활동비 등을 지원한다.

▣ 부록 (Appendix)

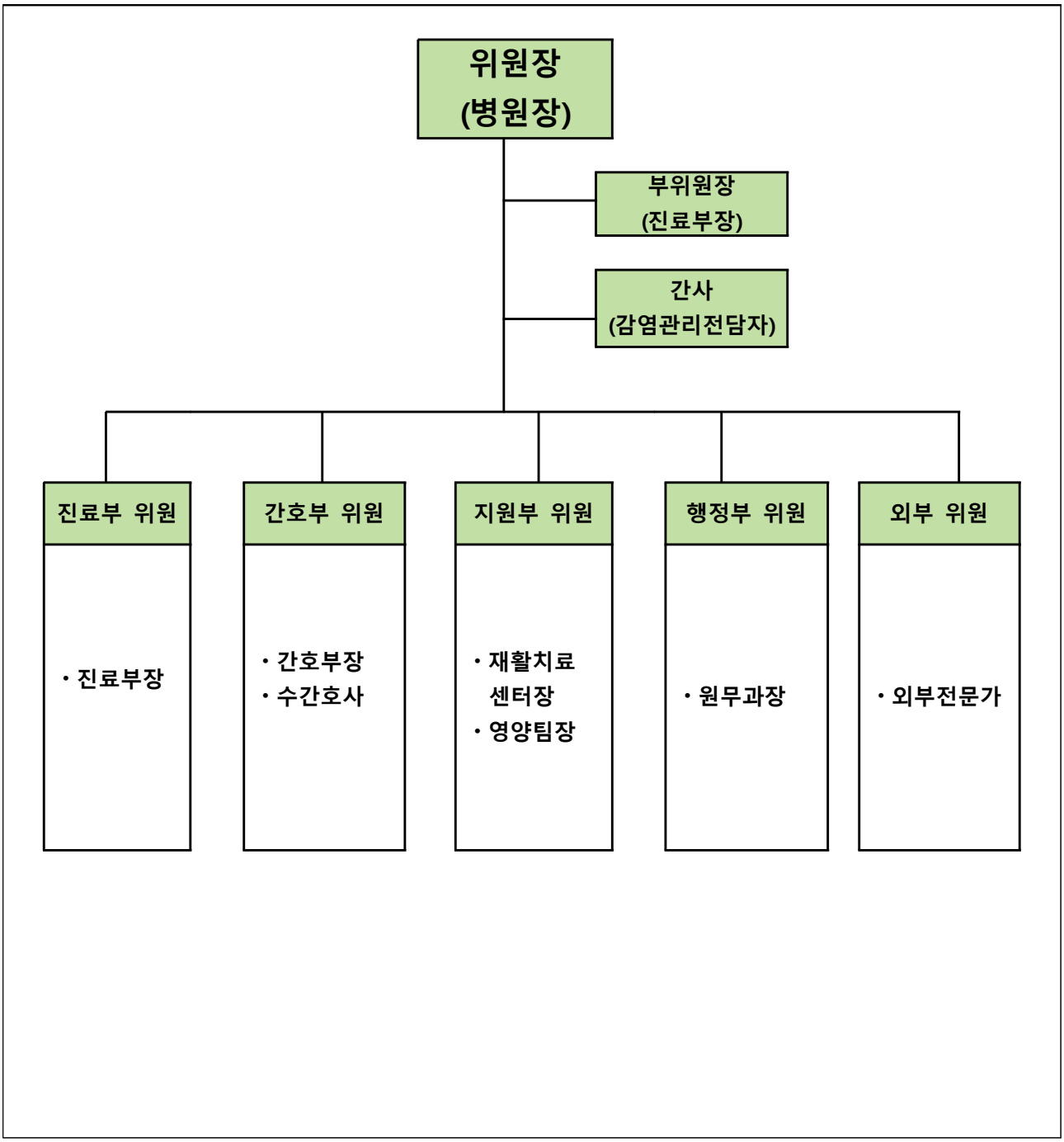
1. 감염관리 위원회 조직도
2. 감염관리 위원회 운영 지침
3. 감염관리 위원회 회의록
4. 연간 감염관리 활동 계획서
5. 감염관리 우선순위 사정도구

▣ 규정 개정일 [누적]

승 인 책 임 자	병 원 장	이름		서명	
승 인 일	. . .				

부록1. 감염관리 위원회 조직도

감염관리위원회 조직도



감염관리 위원회 운영 내규

제1조 (목적)

1. 본 내규는 네이처요양병원(이하 '병원'이라 한다)의 병원감염의 예방대책을 심의하고 감염관리에 필요한 기준을 확립하여 병원에서 발생할 수 있는 감염을 예방하며, 이를 통해 병원을 출입하는 환자에 대한 진료수준의 향상 및 직원, 일반인의 보건증진에 기여함을 목적으로 한다.

제2조 (적용범위)

1. 병원의 감염관리 위원회의 구성 및 운영에 관하여 타 규정에 별도로 정한 것을 제외하고는 본 내규에서 정하는 바에 의한다.

제3조 (위원회의 구성)

1. 위원회의 위원장은 병원장이 되며, 간사 및 위원은 다음 각호와 같다.

가. 간사 : 감염관리전담자

나. 위원 : 병원장, 진료부장, 간호부장, 3병동 수간호사, 재활치료센터장, 영양팀장, 원무과장, 외부위원

제4조 (위원회의 기능)

1. 위원회는 병원 내의 효율적인 감염관리를 위하여 다음 각호의 내용을 관장 및 결정한다.

가. 의료 관련 감염에 대한 대책에 관한 사항

나. 연간 감염관리 계획의 수립 및 시행, 평가에 관한 사항

다. 감염병 환자, 감염병 의사환자 또는 병원체 보유자의 처리에 관한 사항

라. 의료 관련 감염의 전반적인 위생관리에 관한 사항

마. 의료 관련 감염관리에 관한 자체 규정의 제정 및 개정에 관한 사항

바. 감염예방 및 관리 활동 수행을 위한 적격한 자 배치에 관한 사항

사. 그 밖에 의료 관련 감염관리에 관한 중요한 사항

제5조 (위원회의 임무)

1. 위원장은 위원회를 대표하고 회의를 총괄한다.
2. 간사는 감염관리 회의 자료의 수집과 관리, 회의록 작성, 관련 부서와의 연락 등 업무를 담당한다.
3. 위원회는 병원감염의 양상을 파악하여 감염원이 될 수 있는 모든 시설과 치료, 처치 등에 대하여 수시로 개선대책을 강구하여 병원장에게 건의하고 이를 시정 조치할 수 있도록 하여야 한다.
4. 위원회에서 결정된 사항은 병원장의 승인을 득하여 관련부서 및 전 부서에 통보하여야 한다.

제6조 (위원회 회의)

1. 위원회는 정기회의와 임시 회의로 운영된다.
2. 정기회의는 분기별 1회 개최하며, 임시 회의는 위원장이 필요하다고 판단되었을 때 개최할 수 있다.
3. 위원회는 재적위원 3분의 2 이상이 소집 요구가 있을 시 개최할 수 있으며, 출석위원 과반수 이상의 찬성으로 가결한다. 가부 동수일 때는 위원장이 결정한다.

제7조 (감염관리 담당자의 지정)

1. 위원장은 지정된 구역 내의 감염관리 업무를 담당하도록 하기 위해 각 부서별로 필요한 수의 인원을 감염관리 담당자로 지정할 수 있으며 별도의 지정이 없는 경우 각 부서별 책임자를 감염관리 담당자로 정한다.

제8조 (병원감염의 보고)

1. 병원감염 발생 시 실무담당 부서별 감염담당자는 계속 파급될 가능성이 현저히 높을 경우 지체없이 이를 위원회에 보고한다.
2. 그 외의 경우는 각 부서별 감염담당자는 감염관리위원회 간사에게 보고하고 간사는 이를 취합하여 위원회에 보고한다.
3. 위원회에서 결정된 사항은 병원장의 승인을 득하여 공표한다.

제9조 (기타)

1. 이 내규에 명시되지 않은 감염관리에 관한 사항은 본 위원회의 심의를 거쳐 병원장의 승인을 득한 후 시행한다.

부록3. 감염관리 위원회 회의록

감염관리위원회 회의록(1차)

일시 : 202 년 월 일

참석현황	참석대상자	
	참석자	
	불참자	

직책	소속	성명	서명
위원장	병원장		(서명)
부위원장	진료부장		(서명)
간사	감염관리실		(서명)
위원	간호부장		(서명)
위원	원무과장		(서명)
위원	재활치료센터장		(서명)
위원	수간호사		(서명)
위원	영양팀장		(서명)
			(서명)
			(서명)

네이처 요양병원 NATURE HOSPITAL

<table>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">감염관리위원회
회의록</td><td rowspan="2">결
재</td><td>감염관리담당자</td><td>감염관리위원장</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>회의구분</td><td colspan="4">■ 정기회의 □ 임시회의</td></tr>
<tr><td>일 시</td><td colspan="2"></td><td>장 소</td><td>1층 회의실</td></tr>
<tr><td>안 건</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>주요논의
및
결정사항</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>미결사항</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>첨부자료</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

부록4. 연간 감염관리 활동 계획서

연간 감염관리 활동 계획서

내 용				담당자	20 년													비고
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	예산	
감염관리 사업	위원회 개최																	
	감염관리 활동 사업 연간계획서 작성																	
	환자집단 유행발생 시 감시 및 발생 조사/개선활동																	
	손위생 수행률 모니터링																	
	손위생 증진활동																	
감염관리 교육	신규직원 교육																	
	전 직원 교육																	
	필요부서 교육(유행발생시, 부서요청시)																	
직원 감염 관리	직원예방 관리	B형간염예방접종																
		인플루엔자예방접종																
	직원건강 검진	신규 채용 검진																
		정기검진	일반검진															
			특수검진															
	직원감염노출관리																	
법정감염병	법정감염병 신고 (법정 감염병 개정 시 업무 반영)																	
환경감시	소독실, CI / BI 확인																	

부록5. 감염관리 우선순위 사정도구

감염관리위험사정(riskassessment)

번호	위험 항목	근거	위험정도			위험점수 (PxSxP)	우선순위
			발생, 노출가능성 (Probability)	심각성 (Severity)	준비, 대처기능 (Preparedness & Response)		
			1-거의 없음 2-가끔있음 3-때때로있음 4-자주있음 5-지속적임	1- 미약 insignificant 2-약함minor 3-보통moderate 4-심각major 5-극심함extreme	1- 준비됨 또는 불가능 2-일부준비.보완불가 3-일부준비,지원가능 4-준비안됨.지원가능		1-24 낮은 위험 25-49 중간위험 50-74 높은위험 75-100매우위험
환자에 영향을 주는 감염위험요인							
A	손위생 관련 감염 위험 요인						
A-1	손위생 수행률	2025년 90%이하	3	3	3	27	중간위험
B	삽입기구 관련 감염 위험 요인						
B-1	유치도뇨관관련 요로감염	2025년 KONIS 참여기관 아님 미조사	2	3	3	18	낮은위험
C	시술/수술 관련 감염 위험요인						
C-1	처치 / 시술부위 감염	2025년 KONIS 참여기관 아님 미조사	1	3	1	3	낮은위험
D	다재내성균 관련 감염 위험요인						
D-1	MRSA	0	1	3	3	9	낮은위험
D-2	MRAB	0	1	3	3	9	낮은위험
D-3	MRPA	0	1	3	3	9	낮은위험
D-4	VRE	0	1	3	3	9	낮은위험

D-5	CRE	0	1	3	3	9	낮은위험
E	감염병 관련 감염 위험 요인						
E-1	법정감염병	CRE(2025년 보유환자 입원 0명, 신규발생 3명) VRE(2025년보유환자입원0명,신규발생2명)	2	3	3	18	중간위험
E-2	격리실 구비 및 사용 지침 준수	1인실 사용	1	3	3	9	낮은위험
E-3	인플루엔자	0	2	3	1	6	낮은위험
E-4	옴	1	2	3	3	18	낮간위험
E-5	결핵	0	1	3	3	9	낮은위험
E-6	지역유행감염병	인플루엔자	1	3	3	9	낮은위험
F	의료 물품관련 감염 위험요인						
F-1	재사용 기구의 부적절한 세척	N	1	2	1	2	낮은위험
F-2	부적절한 소독제 선택	N	1	1	1	1	낮은위험
F-3	소독제 희석농도, 침적시간 미준수	N	1	1	1	1	낮은위험
F-4	부적절한 고수준소독	N	1	1	1	1	낮은위험
F-5	부적절한 멸균 과정	N	1	2	3	6	낮은위험
F-6	멸균기의 부적절한 관리	N	1	2	3	6	낮은위험
F-7	세척, 소독, 멸균물품의 부적절한 운반	N	1	1	1	1	낮은위험
F-8	소독/멸균물품의 부적절한 보관	N	1	2	3	6	낮은위험

G	환경관련 감염 위험요인						
G-1	청결, 오염구역 혼재	N	1	2	1	2	낮은위험
G-2	환경표면의 정기적, 적절한 청소 및 소독	Y	1	2	3	6	낮은위험
G-3	건축이나 리모델링관련 감염위험	N	1	2	3	6	낮은위험
H	지역사회 감염위험요인						
H-1	지리적 특성관련(예; 휴전선, 바다인접, 홍수, 태풍 등) 감염위험요인	없음	1	2	3	6	낮은위험
H-2	지역사회 인구분포관련(외국인, 노인 등) 감염위험요인	없음	1	3	3	9	낮은위험
직원에게 영향을 주는 감염위험요인							
I	감염질환 노출						
I-1	혈액매개질환노출(주사침 손상 등)	0	2	3	3	18	낮은위험
I-2	수두노출	0	1	1	1	1	낮은위험
I-3	결핵노출	0	1	3	3	9	낮은위험
I-4	옴노출	0	1	3	3	9	낮은위험
J	소독제 등 화학물질 노출						
J-1	피부나 점막 노출	0	1	2	3	6	낮은위험